

透析患者さんの食事療法

—しっかり食べて、しっかり透析、元気で長生き—

適切な食事管理は、合併症を予防します

透析患者さんの食事療法

健康な腎臓の働き

-1-

血液をろ過して尿をつくり、体に必要のない水分、塩分、老廃物を体外に出す

-2-

体内の水分量をコントロールし、体液に含まれるナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、リンなどのバランスを保つ

-3-

血圧をコントロールするホルモンや赤血球をつくる造血ホルモンを生成する

-4-

ビタミンDを活性型ビタミンDに変え、骨へのカルシウム定着を促す

-5-

体内で作られた酸性物質を尿中に排泄し、また腎臓から血液中に重炭酸イオンを放出することで酸性物質を中和して体の酸とアルカリのバランスを調整する

透析患者さんではこれらの働きができなくなるため、体に水分が溜まりむくみやすくなる、血中のカリウムやリンが増加傾向がみられる、高血圧になる、貧血傾向になる、カルシウムが骨から溶け出すなどの様々な症状が起きやすくなります。

透析によって腎臓の代わりはできますが、すべて同じように代わりがきくわけではありません。また、その日の体調によっては、透析が予定通りきちんとできない場合もあります。透析の働きを補うために、お薬や毎日のお食事で治療を行います。

透析食事療法の基本

1. エネルギーの適量摂取
2. たんぱく質の適量摂取
3. リン制限
4. カリウム制限
5. 水分制限
6. 食塩制限

1. エネルギーの適量摂取

透析患者さんは尿毒素の蓄積による食欲不振や慢性炎症などの影響で、エネルギー摂取不足となり低栄養に陥りやすくなります。エネルギー摂取不足は体重やとりわけ筋肉量の減少をきたし、体力・免疫力の低下、栄養不足につながります。反対にエネルギー摂取の過剰では、高脂血症などの症状から、動脈硬化などにつながります。

◎エネルギーの摂取量は「標準体重×30～35kcal」とされていますが、性別、年齢、合併症などにもよるため、詳しくは医師、管理栄養士にご相談ください。

（日本透析医学会学術委員会 慢性透析患者の食事療法基準より）

2. たんぱく質の適量摂取

たんぱく質食品を必要以上に食べるとリンが増えやすくなります。逆に、たんぱく質の摂取量が少ないと、透析によりアミノ酸やたんぱく質の喪失があるため低栄養状態になってしまいます。

◎たんぱく質の摂取量は「標準体重×0.9～1.2g」で計算できます。

（日本透析医学会学術委員会 慢性透析患者の食事療法基準より）

3. リン制限

たんぱく質を多く含む食品にはリンが多く含まれており、1回の透析で除去できるリンは、食事から摂取した量の約3割といわれています。透析で除去できないリンは、薬や食事内容でコントロールする必要があります。特にリンが多く含まれる食品は、乳製品、小魚、内臓類であり、加工食品に含まれる無機リンは、体内への吸収率が高いため少量でも注意が必要です。

◎透析患者さんの血中リン(P)の管理目標値は3.5～6.0mg/dLです。

（健常者の基準値＝2.5～4.5mg/dL）

4. カリウム制限

食事を通して摂取したカリウムは、本来、尿中から排泄されますが、腎臓の働きが悪くなると尿量が減り、カリウムのコントロールがうまくいかず、高カリウム血症になりやすくなります。血中のカリウム濃度が高くなると心臓へ負担がかかり、ひいては心停止となる場合もあります。透析を行うことである程度のカリウム除去が可能です。過剰な野菜・果物、海藻類の摂取は、高カリウム血症の要因になりますので、食べる量には注意が必要です。

◎透析患者さんの血清カリウム(K)の管理目標値は3.5～5.5 mEq/Lです。

◎血清カリウム濃度が3.5 mEq/Lを下回るような場合は、栄養指導いたします。

(健常者の基準値 = 3.5～5.0 mg/dL)

● カリウムを多く含む食品



● カリウムを減らす工夫をしましょう

ゆでこぼし



水にさらす



5. 水分制限

慢性腎不全になると徐々に尿量が減ります。そのため水分をたくさん取ると、体重増加やむくみの要因となります。体重が増えすぎると、限られた時間で透析を行えなくなり、増えた水分を全部取り除くことができなくなります。次の透析までの間、定期的に体重を測るようにしましょう。透析間の体重増加が中1日の場合はドライウェイト(DW)の3%、中2日では5%までにとどめることが理想です。

◎ドライウェイト(DW)とは、透析で体液管理を行う際に目標とする体重で、「体液量が適正で、透析中に過度の血圧低下を生じることなく、かつ長期的にも心血管系への負担が少ない体重」と定義されます。

ドライウェイト(DW)の設定は、胸部エックス線写真による心胸比や血液透析中の血圧変化などをみて行います。

～理想体重増加量～



中1日 = 3%
中2日 = 5%
(ドライウェイトから)



6. 食塩制限

食塩の多い食事を食べていると、のどの渇きが誘発され水分を多くとる傾向にあります。また、食塩の過剰摂取は循環血液量の増加を引き起こし、血圧上昇につながります。循環血液量が増加しすぎると、心不全や呼吸不全を引き起こすこともあります。

慢性腎臓病の患者さんでは、どの病期においても1日3g以上6g未満の食塩制限があります。

(慢性腎臓病ガイドラインより)

味付けがしょうゆ主体か、マヨネーズなどの洋風かで食塩量が異なり、洋風の味付けの方が食塩量は少なくなります。薬味や香辛料を上手に取り入れて食塩の量を減らしましょう。近年では生活スタイルの変容で、中食や外食の利用が増え、それに伴って食塩摂取量が多くなっています。コンビニのお弁当では追加のソースをかけない、漬物を食べないなどで摂取量を調整しましょう。

—しっかり食べて、しっかり透析、元気で長生き—
適切な食事管理は、合併症を予防します